患者自主书写病历及主导医疗决策的可行性探究

摘要

在当前医疗环境下，临床科研压力巨大，病历书写要求严苛且耗费大量时间，这使得医生在专注科研与诊疗工作上受到严重影响。基于此背景，本研究探讨患者自主书写病历及主导医疗决策这一创新模式。该模式设想患者依据自身症状描述书写病历，并在一定范围内主导医疗决策，如选择检查项目与确定手术方案。然而，实施过程中面临患者专业医学知识不足、医生角色转变困难以及医疗风险与责任界定模糊等挑战。针对这些问题，提出加强患者医学教育、建立医生引导与协助机制以及完善医疗风险防范与责任界定体系等应对策略。研究发现，此模式若能有效实施，可能对医患关系、医疗效果及医疗资源分配产生深远影响，为医疗模式创新提供新的思路与方向。

关键词: 患者自主；病历书写；医疗决策；困难挑战；应对策略

1. 引言

1.1 临床科研压力与病历书写现状

当前，临床医学领域的科研任务日益繁重，医生在承担日常诊疗工作的同时，还需投入大量精力进行科学研究，这种双重压力对医疗体系的高效运转构

成了严峻挑战。根据相关调查数据显示，医生每天用于病历书写的时间占比高达近四成，而这一比例在部分科室甚至更高[2]。病历书写作为医疗行为的重要组成部分，其规范要求严格且内容繁杂，包括接班记录、转入记录以及阶段小结等均需在特定时间内完成。例如，86%的医师认为接班记录应于接班后 24 小时内完成，而 55%的医师则对阶段小结的书写时限表示无需修改[2]。然而，这种高强度的病历书写要求不仅占用了医生大量的时间，还导致其与患者直接接触的机会大幅减少，从而影响了医疗质量和科研效率。此外，一线医务人员因病历书写任务过重，已出现“写”得太多而无暇顾及临床工作的现象，这进一步凸显了现行病历书写制度的局限性[9]。

1.2 引出患者自主写病历的设想

基于上述临床科研压力与病历书写现状，提出让患者自主书写病历及主导医疗决策的设想，旨在探索一种能够缓解医生工作负担并优化医疗流程的新思路。近年来，随着医疗模式的不断创新，患者参与医疗决策的理念逐渐受到关注，但由患者完全主导病历书写及医疗决策的实践仍属空白领域[15]。该设想的核心在于重新定位病历的功能，将其从传统的医务人员工作日记转变为患者与医生共同协作的诊疗工具。通过让患者根据自身症状描述和病史记录完成病历书写，并在此基础上参与医疗决策，不仅可以减轻医生的文字负担，还能增强

患者对自身健康的认知与责任感。这一设想契合了当前医疗模式转型的需求，为解决临床科研压力与病历书写矛盾提供了新的可能性[15]。

1.3 研究目的与意义

本研究旨在深入探讨患者自主书写病历及主导医疗决策这一创新性设想的可行性、潜在影响及其应对策略，以期为医疗模式的优化提供理论参考。具体而言，本研究将从患者角度出发，分析其是否具备准确描述症状和合理选择医疗决策的能力；同时，也将考察医生在角色转变过程中可能面临的困难与挑战。通过对这些问题的系统研究，不仅可以为未来医疗模式的创新设计提供科学依据，还有助于缓解临床医生在科研与病历书写之间的两难处境，进而提升整体医疗效率[5]。此外，本研究还将结合信息链视域下的电子病历数据驱动模型，探讨如何利用现代技术手段支持患者自主书写病历的实践，为构建更加人性化和高效的医疗体系奠定基础[5]。

2. 文献综述

2.1 传统病历书写模式研究

传统病历书写模式以生物医学实践为核心，其主要内容包括对患者的症状、体征、诊断、治疗及预后等信息的记录。病历书写通常遵循严格的规范与流程，例如《病历书写基本规范》明确了入院记录、病程记录等表单的具体要求，确

保医疗信息的准确性和完整性[3]。在这一模式下，病历不仅是医疗行为的重要记录载体，也是医疗质量评估、科研数据分析以及医疗纠纷处理的关键依据。然而，现有标准化病历主要关注疾病诊断与治疗的技术性内容，而忽视了患者心理与社会层面的需求。例如，在入院记录中，尽管“现病史”部分要求记录患者的疾病发生与演变过程，但并未明确纳入人文医学实践的书写范式，导致病历内容缺乏对患者主观感受与情感体验的关注[3]。此外，疫情期间的新冠肺炎病历管理进一步凸显了病历书写的重要性，要求医务人员不仅需按照规范及时、准确地记录患者的流行病学信息与诊疗过程，还需进行精确的编码以确保数据统计与检索的有效性[10]。由此可见，传统病历书写模式在医疗实践中具有不可替代的作用，但其局限性也逐渐显现，尤其是在满足患者个性化需求与人文关怀方面。

2.2 患者参与医疗决策的研究进展

近年来，患者参与医疗决策的研究逐渐成为医学领域的热点话题。国内外学者从不同角度探讨了患者参与医疗决策的程度、方式及其对医疗效果的影响。研究表明，患者参与医疗决策能够显著提高其治疗依从性与满意度，同时有助于改善医患关系[4]。在叙事医学视角下，写作教育被视为培养医学生叙事思维与能力的重要途径，强调通过语言表达能力提升医患沟通的质量。这一理念同

样适用于患者群体，即通过增强患者的叙事能力，使其能够更清晰地表达自身需求与偏好，从而更深入地参与医疗决策过程[7]。此外，人工智能技术的发展也为患者参与医疗决策提供了新的可能性。例如，ChatGPT 等人工智能工具可以协助患者完成病历书写与查房记录整理，提高信息录入的精准性与效率，同时为医生提供更为全面的患者信息支持[4]。然而，当前研究多集中于患者参与决策的辅助手段，而对其在医疗决策中的主导作用探讨较少。因此，如何在现有研究基础上进一步拓展患者参与的范围与深度，仍是亟待解决的问题。

2.3 本研究的切入点

通过对传统病历书写模式与患者参与医疗决策研究的对比分析，可以发现两者均存在一定局限性。传统病历书写模式过于注重生物医学实践，忽视了患者的人文需求；而现有患者参与医疗决策的研究则多停留在辅助层面，未能充分探讨患者在医疗决策中的主导作用。基于此，本研究提出了一种创新性设想，即让患者自主书写病历并主导医疗决策。这一模式的独特之处在于，它不仅强调患者作为医疗主体的核心地位，还试图通过患者自主书写病历的方式，弥补传统病历中人文关怀的缺失[11]。同时，该模式尝试重新定义医生与患者的角色关系，将医生从繁重的病历书写任务中解放出来，使其能够更加专注于科研与诊疗工作。然而，这一创新点也面临着诸多挑战，如患者专业医学知识不足、

医生角色转变困难以及医疗风险与责任界定模糊等问题。因此，本研究旨在系统分析这些潜在问题，并提出相应的应对策略，为未来医疗模式的创新提供理论参考与实践指导[11]。

3. 患者自主写病历及主导医疗决策的方式

3.1 患者自主写病历的方式

3.1.1 基于症状描述的病历书写

患者在自主书写病历时，首先需要根据自身感受对症状进行详细描述。这一过程要求患者尽可能准确地记录症状的发生时间、部位及严重程度等信息，为医生提供可靠的诊断依据。例如，患者可通过对症状的时间维度进行精确刻画，如“咳嗽持续三天，每天早晨尤为明显”，以帮助医生判断病情的进展情况[1]。此外，症状的部位描述也需具体化，例如“右上腹疼痛，放射至右肩部”，这有助于医生定位病变区域并制定进一步的检查方案。在描述症状程度时，患者可以采用量化或半量化的方式，如“疼痛评分为 7 分（满分 10 分）”，从而增强症状描述的客观性。值得注意的是，由于患者的医学知识有限，其描述可能包含口语化表达，因此需要借助自然语言处理技术对症状描述进行结构化处理，将其转化为医学术语。例如，将“一阵一阵地咳”归一化为“阵发性咳嗽”，以提高病历的规范性和可用性[1]。

3.1.2 病史与过往治疗记录呈现

除了症状描述外，患者还需整理和呈现个人病史及过往治疗记录，以便医生全面了解病情。病史内容应包括既往疾病、手术史、用药情况以及过敏史等关键信息。例如，患者可通过回顾自身的医疗档案或记忆，详细列出曾患疾病的名称、发病时间及治疗结果，如“2018 年诊断为高血压，长期服用缬沙坦控制血压”[6]。对于手术史，患者应提供手术名称、手术时间及术后恢复情况等信息，这些记录能够帮助医生评估患者的手术耐受性及潜在并发症风险。同时，患者还需记录当前正在使用的药物名称、剂量及用药频率，并注明是否存在药物不良反应。为了确保病史信息的完整性与准确性，患者可借助电子病历系统或其他健康管理工具进行辅助记录。结构化电子病历的应用能够有效地将患者的病史信息集中化管理，并通过模板化的设计引导患者填写关键信息，从而减少信息遗漏的可能性[6]。

3.2 患者主导医疗决策的方式

3.2.1 检查项目选择

在患者主导医疗决策的模式下，检查项目的选择是患者依据自身症状和对疾病的理解所做出的重要决策之一。患者可根据自身症状的特点，结合初步的医学知识，提出可能需要的检查项目。例如，若患者出现持续性胸痛的症状，

可能倾向于选择心电图、心肌酶谱检测等项目以排除心血管疾病[5]。然而，由于患者对疾病的认知往往局限于表面现象，其选择的检查项目可能存在片面性或冗余性。因此，在此过程中，医生的专业指导显得尤为重要。医生可通过向患者解释不同检查项目的目的、适用范围及局限性，帮助患者优化选择。此外，电子病历系统的智能化功能也可为患者提供支持。例如，系统可根据患者输入的症状信息，自动推荐相关的检查项目清单，并显示各项目的优先级及必要性说明，从而提升患者决策的科学性[5]。

3.2.2 手术方案确定

在涉及手术治疗的决策中，患者需在医生的建议下综合考虑自身意愿、手术风险及预期效果等因素，最终确定手术方案。患者的意愿通常受到其个人价值观、生活方式及心理状态的影响。例如，某些患者可能因担心术后恢复时间过长而倾向于选择微创手术，即使传统手术的疗效更为确切[8]。与此同时，医生需向患者详细解释不同手术方案的风险与收益，包括手术成功率、并发症发生率及术后康复周期等信息，以帮助患者做出知情选择。为了增强患者对手术方案的理解，可视化工具和模拟技术可被用于展示手术过程及预期结果。此外，电子病历系统中的科研病历模板也可发挥作用。通过整合患者的病史数据及检查结果，模板能够生成个性化的手术风险评估报告，为患者和医生提供更为全

面的参考依据[8]。最终，手术方案的确定应体现患者自主性与医生专业性的有机结合，从而实现最佳的治疗效果。

4. 实施过程中的困难与挑战

4.1 患者专业医学知识不足

患者在疾病认知和医学知识方面的局限性，是实施自主书写病历及主导医疗决策模式的首要障碍。由于医学领域的高度专业性和复杂性，普通患者往往难以准确描述自身症状的发生时间、部位、程度等关键信息，从而导致诊断依据的不完整或偏差。此外，患者对疾病的病理机制、治疗方案的选择以及潜在风险的理解不足，可能使其在医疗决策中倾向于片面或错误的判断[4]。例如，在缺乏系统医学教育的情况下，患者可能无法区分某些症状的轻重缓急，或者对特定检查的必要性和局限性产生误解。这种知识鸿沟不仅影响患者自主书写病历的质量，还可能导致其在医疗决策中表现出过度依赖或完全排斥医生建议的极端行为[7]。因此，如何通过有效的健康教育手段提升患者的医学素养，成为该模式实施过程中亟待解决的重要问题。

4.2 医生角色转变困难

在传统医疗模式中，医生作为医疗行为的主导者，承担着诊断、治疗和决策的核心职责。然而，若将患者自主书写病历及主导医疗决策作为新模式推行，

则要求医生从主导者转变为执行者与协助者，这一角色转变对医生的职业观念和工作习惯提出了严峻挑战。首先，医生需要重新审视自身的职业定位，从传统的“权威型”角色向更加注重患者参与的“协作型”角色过渡，这往往伴随着心理上的不适应和抵触情绪[9]。其次，长期形成的职业习惯使得医生在诊疗过程中更倾向于主动掌控全局，而新模式要求他们在患者自主决策的基础上提供支持，这种工作方式的调整需要较长时间的适应和培训。此外，部分医生可能担心角色转变会削弱其在医疗团队中的影响力，甚至对职业发展产生负面影响，这也进一步加剧了角色转变的难度[15]。因此，如何通过制度设计和职业培训引导医生顺利实现角色转变，是该模式成功实施的关键环节之一。

4.3 医疗风险与责任界定模糊

患者自主决策可能带来一系列医疗风险，并在出现不良后果时引发医生与患者之间的责任界定难题。一方面，由于患者对疾病认知的局限性，其自主选择的检查项目或治疗方案可能存在不合理性，甚至可能导致误诊、漏诊或过度治疗等问题。例如，患者可能基于对某种疾病的误解而坚持进行不必要的侵入性检查，从而增加身体负担和经济成本[10]。另一方面，当患者自主决策导致不良后果时，如何在法律框架内明确医生与患者的责任分配，成为亟待解决的伦理和法律问题。现行医疗法律法规通常将医疗责任主要归属于医生，但在患者

自主决策的情境下，这种责任划分方式可能显得过于单一或不公平。例如，若患者坚持拒绝某项必要的治疗措施，最终导致病情恶化，医生是否应承担全部责任？此类问题的存在不仅增加了医生的职业风险，也可能削弱患者对新模式的信任感[10]。因此，完善医疗风险防范机制并明确责任界定标准，是保障该模式顺利实施的重要前提。

5. 应对策略

5.1 加强患者医学教育

在患者自主书写病历及主导医疗决策的新模式下，提升患者对疾病和医疗知识的认知水平是确保其可行性的关键。通过科普宣传、健康教育课程等方式，可以有效增强患者的医学素养，使其能够更准确地描述症状并理解治疗方案。例如，医疗机构可通过举办定期的健康讲座或在线教育平台，向患者普及常见疾病的症状学知识、诊断流程以及治疗选项[7]。此外，结合叙事医学的理念，医疗机构可以设计针对性的写作训练课程，帮助患者以结构化的方式记录自身病情，从而提高病历的可用性与准确性。这种教育方式不仅有助于患者更好地参与医疗决策，还能减轻因专业知识不足而导致的焦虑与误解，为医患双方的有效沟通奠定基础。

5.2 医生引导与协助机制建立

尽管患者自主书写病历及主导医疗决策的模式强调患者的主体性，但医生的专业引导与协助仍然不可或缺。在新模式下，医生需从传统的主导者角色转变为协助者，利用其专业知识帮助患者做出合理决策。例如，在患者选择检查项目或制定手术方案时，医生可以通过详细解释各项检查的必要性及其潜在风险，引导患者做出更为理性的选择[1]。同时，医生还可借助信息技术工具，如人工智能辅助诊断系统，为患者提供个性化的建议，确保决策的科学性与安全性。此外，建立有效的医患沟通机制也至关重要。通过采用共情式沟通技巧，医生可以帮助患者更好地理解复杂医学信息，并在尊重患者意愿的基础上达成共识，从而实现医患共同决策的目标[11]。

5.3 完善医疗风险防范与责任界定体系

患者自主书写病历及主导医疗决策的模式在提升患者参与度的同时，也可能带来一定的医疗风险与责任界定难题。为此，必须从制度建设与保险保障等方面完善相关机制，以降低潜在风险并明确各方责任。首先，医疗机构应制定详细的操作规范，明确患者在不同医疗环节中的权利与义务，确保其行为符合医疗伦理与法律法规的要求[5]。其次，引入医疗责任保险制度，可为医患双方提供经济保障，减轻因医疗失误而引发的纠纷。例如，在出现不良后果时，保险公司可根据事先约定的责任划分承担赔偿责任，从而缓解医患之间的矛盾

[10]。此外，通过构建多学科协作团队，可以在患者自主决策过程中提供全面的技术支持与风险评估，进一步降低医疗风险的发生概率。综上所述，完善的医疗风险防范与责任界定体系不仅是新模式顺利实施的重要保障，也是推动医疗模式创新的关键环节。

6. 新模式的影响分析

6.1 对医患关系的影响

患者自主书写病历及主导医疗决策的新模式将对医患关系产生深远影响，尤其是在沟通方式、信任程度以及权力分配方面。传统医患关系中，医生通常占据主导地位，患者更多扮演被动接受的角色，而新模式则强调患者的主动参与和决策权。这种转变可能促进医患之间的双向沟通，患者通过详细记录自身症状和病史，能够更清晰地表达需求与期望，从而增强信息传递的准确性[7]。此外，患者在医疗决策中承担更多责任，有助于提升其对医生的信任感，因为这种模式体现了医生对患者意愿的尊重与支持。然而，权力分配的调整也可能引发新的问题，例如部分患者对医疗知识的理解有限，可能导致其对医生建议的质疑或误解，进而影响医患间的合作关系[11]。因此，构建新型医患关系需要以有效的沟通机制为基础，同时注重培养患者的医学素养与医生的引导能力，以实现双方权力的平衡与协作。

6.2 对医疗效果的影响

新模式对疾病诊断准确性、治疗有效性及患者康复情况的影响需从理论与实践两个层面进行探讨。在疾病诊断方面，患者自主书写病历能够为医生提供更为全面的症状描述和个人病史信息，这在一定程度上可以提高诊断的准确性。然而，由于患者对疾病的认知可能存在偏差，其提供的信息未必完全客观或科学，这就要求医生在诊断过程中仍需结合专业知识进行判断[4]。在治疗有效性方面，患者主导医疗决策的方式可能使治疗方案更加个性化，符合患者的实际需求与价值观。但与此同时，患者缺乏专业医学知识可能导致其选择不合理的检查项目或手术方案，从而降低治疗的有效性。例如，某些患者可能倾向于过度检查或选择高风险手术，而忽视医生的专业建议[8]。在患者康复情况方面，新模式的优势在于增强了患者的参与感与责任感，这可能有助于提高其依从性并促进康复。然而，若患者在决策过程中出现失误，则可能导致康复进程受阻。因此，新模式对医疗效果的影响取决于患者与医生之间的协作程度，以及患者自身医学素养的提升空间。

6.3 对医疗资源分配的影响

新模式的实施可能引发医疗资源分配的不均衡问题，特别是在部分患者过度占用资源的情况下。一方面，患者自主选择检查项目和手术方案可能导致医

疗资源的浪费，例如某些患者因对疾病认知不足而要求进行不必要的检查，或者选择高成本但低效益的治疗方案[5]。这种行为不仅增加了医疗系统的经济负担，还可能导致其他患者无法及时获得所需的医疗资源。另一方面，新模式可能加剧医疗资源分配的地区差异，因为经济发达地区的患者通常具备更强的健康素养和经济能力，能够更好地利用医疗资源，而经济欠发达地区的患者则可能因知识匮乏或经济条件限制而无法充分参与决策[5]。为解决这些问题，建议从制度设计和技术支持两方面入手优化资源分配。首先，应建立科学的医疗决策辅助系统，通过人工智能或大数据技术帮助患者做出理性选择，避免资源浪费。其次，应加强医疗资源的宏观调控，确保资源分配的公平性与可及性，例如通过政策引导和财政补贴支持弱势群体获取必要的医疗服务[5]。此外，还需完善医疗保险制度，将患者自主决策纳入风险管理体系，从而减轻因不合理决策导致的资源浪费问题。

7. 结论

7.1 研究总结

患者自主写病历及主导医疗决策的方式作为一种创新性的医疗模式，在理论探讨中展现了其潜在的可行性与价值。本研究通过系统分析该模式的实施方式，发现患者在症状描述、病史记录、检查项目选择以及手术方案确定等方面

具备一定的自主能力，这为减轻医生工作负担和优化医疗流程提供了新思路[1][5]。然而，实施过程中也暴露出诸多困难与挑战，尤其是患者专业医学知识不足、医生角色转变困难以及医疗风险与责任界定模糊等问题，成为制约该模式推广的主要障碍[4][9]。为此，本研究提出了加强患者医学教育、建立医生引导与协助机制以及完善医疗风险防范与责任界定体系等应对策略，旨在通过多方面的努力克服上述困难[7][10]。此外，新模式对医患关系、医疗效果及医疗资源分配的影响亦需引起关注。研究表明，该模式可能改变医患之间的沟通方式与信任程度，并对疾病诊断准确性及治疗有效性产生深远影响，同时还需警惕医疗资源不合理分配的风险[4][11]。

7.2 研究展望

尽管患者自主写病历及主导医疗决策的模式尚处于理论探索阶段，但其在未来医疗实践中的应用前景值得期待。随着信息技术与人工智能的快速发展，结合新技术优化该模式将成为重要的研究方向。例如，通过开发智能化的病历书写工具和医疗决策辅助系统，可以帮助患者更准确地描述症状和选择检查项目，从而提升决策的科学性与合理性[5]。此外，虚拟现实技术（VR）和增强现实技术（AR）的应用也可能为患者提供更为直观的医学知识学习途径，进一步弥补其专业知识不足的短板[7]。在医患关系方面，新模式或可推动构建更加平

等和谐的医患互动模式，但需通过大规模实证研究验证其实际效果[11]。同时，未来的研究还应关注如何将该模式与现有的医疗法律法规相衔接，确保在责任界定和风险防范方面有章可循[10]。总之，患者自主写病历及主导医疗决策的模式不仅是医疗模式创新的一次尝试，也为未来医疗体系的人性化与高效化发展提供了重要参考[15]。

参考文献

[1] 姜会珍;胡海洋;马琏;赵从朴;张锋;陈婕卿;曾可;王晓露;朱卫国.基于医患对话的病历自动生成技术研究[J].中国数字医学,2021,16(10):36-40.

[2] 费菲;曲莉莉;赵海.改吗?!46%的医师上班近 4 成时间写病历 本刊《病历书写基本规范》20 月调查结果新鲜出炉[J].中国医药科学,2017,7(21):1-8.

[3] 何小菁;季国忠.双轨病历构建[J].医学与哲学,2022,43(6):40-45.

[4] 陶嘉雯;余争平;皮会丰.浅析以 ChatGPT 为代表的人工智能对医学教育的影响[J].数理医药学杂志,2023,36(6):475-480.

[5] 杨鑫禹;牟冬梅;丁丽芳;王萍;叶书含;李桦;张紫卉.信息链视域下电子病历数据驱动临床决策的需求模型构建[J].现代情报,2024,44(4):66-76.

[6] 樊少辉.基于结构化电子病历导向的医院信息化平台建设探讨[J].中国管理信息化,2017,20(22):57-58.

[7] 薛昭曦.基于叙事医学视角的医学生写作教育探讨与思考[J].福建医科大学学报（社会科学版）,2023,24(2):29-33.

[8] 黄蓓丽;梅甜;李湘平;王文辉.电子病历数据的临床及科研应用[J].医学信息学杂志,2017,38(8):11-14.

[9] 章尚乐;陈文胜;陆伟良;张文家.简化病历书写的思考与探讨[J].中国医院,2013,17(7):76-77.

[10] 周蝶;李红樱;陈怡;明星宇;杨晓燕;吴佳玉.论新型冠状病毒肺炎疫情期间病案防控与管理要点——以某三甲医院为例[J].医学与社会,2021,34(7):93-97.

[11] 苏业璞;张颖;秦莉;王俊明.创新思维推动传统病历适应叙事医学发展[J].医学与哲学（B）,2016,37(10):82-84.

[12] 吴侗;陈康;陈锋;苏明华;孙颖.方舱云 HIS 系统新型冠状病毒肺炎患者病历的设计及应用[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2021,16(8):845-848.

[13] 孙慧子;董晓明;刘宇.公立医院绩效考核的病案首页数据质量现状分析[J].中国医院管理,2022,42(8):61-63.

[14] 倪静;孙娜;蔡文军;刘芳;刘小燕.新型冠状病毒肺炎救治中病历管理的探讨[J].西南军医,2021,23(4):490-491.

[15] 张益娟;李杏.精简病历的可行性与现实意义[J].医疗装备,2015,28(12):57-58.